

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรม ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

The development of smoking cessation promotion model
by using innovation media among patients with noncommunicable diseases

ธนะวัฒน์ รวมสุข* พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน* ชันทิพย์ พลอยสุวรรณ* ชุตินา ปัญญาพินิจนุกร*

และ สุพิชญ์รดา คำบอนพิทักษ์**

Tanawat Ruamsook,*, Pimpat Chantian,* Chunthip Ploysuwan,* Chutima Panyapinijnugoon ,*

and Suphitrada Kombonpituk**

*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

** โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

*Faculty of Nursing, Kasem Bundit University

** Bang Nam Piao Hospital, Chachoengsao Province

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่และรูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ พัฒนาและศึกษาผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเลิกบุหรี่ 5 คน และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่ ในระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 10 คน และในระยะศึกษาผลของรูปแบบ 27 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบวัดความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการทดสอบที ผลพบว่า ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางรายยังสูบบุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่เป็นการให้คำแนะนำโดยการพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การชักประวัติการสูบบุหรี่และประเมินผู้ป่วย การประเมินความพร้อม ระดับการติดนิโคติน ผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยใช้ชุดสื่อนวัตกรรม การกำหนดวันเลิกสูบบุหรี่ และการติดตามผล หลังการใช้รูปแบบฯ พบว่า ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และระดับการติดนิโคตินต่ำกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) และความพึงพอใจต่อรูปแบบของบุคลากรด้านสุขภาพและผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: การเลิกบุหรี่, สื่อนวัตกรรม, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

Corresponding author E-mail: pimpat.cha@kbu.ac.th

วันที่รับบทความ: 21 ธันวาคม 2567 วันที่แก้ไขบทความ: 14 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 25 กุมภาพันธ์ 2568

การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในหน่วยบริการสุขภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติสูบบุหรี่และเน้นการบำบัดรักษาด้วยวิธีการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2565) องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป้าหมายหลัก 9 ข้อ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วง ค.ศ.2025 โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้คือ ความชุกของการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง ร้อยละ 30 (World Health Organization, 2017) เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต

การสำรวจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2567 พบว่า ในปี 2564, 2565 และ 2566 มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 0.8, 12.5 และ 15.0 ตามลำดับ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะได้รับการคัดกรองพฤติกรรมและประวัติการสูบบุหรี่โดยการสอบถามประวัติการสูบบุหรี่ จำนวนที่สูบ และความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่จากพยาบาลคัดกรองในคลินิกโรคเรื้อรัง บางส่วนยังไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่จะส่งผลต่อโรคที่เป็นอยู่ของตนเองอย่างไร จากการศึกษาของ ชนิตา รำขำวิญญู และคณะ (2559) พบว่า การรับรู้ความรุนแรงและอันตรายของโรค มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างสำเร็จและต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health belief model) ที่มีปัจจัยทำนายพฤติกรรมของบุคคลในการมีสุขภาพที่ดี โดยการได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรค ความรุนแรงของการเกิดโรค อุปสรรคของการหลีกเลี่ยงปัญหาทางสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค (Rosenstock, 1974) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องนี้ ในปัจจุบันการใช้สื่อนวัตกรรมถูกนำมาให้บริการสุขภาพและการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการช่วยเลิกบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกัน (ภาววิณี แสงจันทร์ และชนนชม ธนานิธิศักดิ์,

2561) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ผ่านนวัตกรรมต่างๆ จะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น (ทิพวัลย์ธีรศิริโรจน์, 2565) รวมไปถึงการมีภาวะสุขภาพที่ดี และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และรูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development [R&D])

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) และเข้ารับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นผู้ที่มีการสูบบุหรี่และยังคงสูบบุหรี่อยู่จนถึงปัจจุบัน

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดอำนาจทดสอบ (power of test) 0.80 ความเชื่อมั่น 0.05 และค่าขนาดอิทธิพล (effect size) 0.50 และนำมาเปิดตาราง (Burns & Grove, 2016) ได้กลุ่มตัวอย่าง 27 คน ผู้วิจัยป้องกัน

การสุ่มหาของกุ่มตัวอย่าง จึงเพิ่มกุ่มตัวอย่างขึ้น
อีกร้อยละ 10 จึงได้กุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน

เครื่องมือวิจัย

1. **แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง** เป็นแนวคำถาม
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งออกเป็น
สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ จำนวน 5 ข้อ และสำหรับ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 7 ข้อ มีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด

2. **แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล**
ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 **ข้อมูลทั่วไป** เป็นแบบเติมคำและ
เลือกตอบ จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 2 **พฤติกรรมกาสูบบุหรื** ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามของธนะวัฒน์ รวมสุข และคณะ (2561)
จำนวน 12 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 3 **แบบประเมินการติดนิโคติน** ของ
Fagerström Test for Nicotine Dependence [FTND]
(Healtherton et al., 1991) มีจำนวน 6 ข้อ คะแนน
10 คะแนน จำแนกระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน
ดังนี้คะแนน 8-10 คะแนน คือ สูงมาก, คะแนน 6-7 คะแนน
คือ สูง, คะแนน 5 คะแนน คือ ปานกลาง, คะแนน 3-4
คะแนน คือ ต่ำ และ คะแนน 0-2 คะแนน คือ ต่ำมาก

ส่วนที่ 4 **ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรื**
พัฒนาจากแบบสอบถามของธนะวัฒน์ รวมสุข และคณะ
(2564) ลักษณะคำตอบเป็นแบบเลือกตอบ ตอบถูก ได้
1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน จำนวน 10 ข้อ คะแนน
0-10 คะแนน คะแนนสูง คือ มีความรู้ระดับดี คะแนนต่ำ
คือ มีความรู้ระดับไม่ดี

ส่วนที่ 5 **ความเชื่อทางด้านสุขภาพ** พัฒนา
จากแบบสอบถามของทิตาวดี สิงห์โค และคณะ (2563)
จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการสูบบุหรื การรับรู้ความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากการสูบบุหรื การรับรู้ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรื และ
การรับรู้อุปสรรคจากการเลิกสูบบุหรื คำตอบเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนสูง
คือ มีความเชื่อทางด้านสุขภาพระดับดี และคะแนนต่ำ คือ
มีความเชื่อทางด้านสุขภาพระดับไม่ดี

ส่วนที่ 6 **การเลิกสูบบุหรื** ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ของธนะวัฒน์ รวมสุข และคณะ (2561) ลักษณะคำตอบ
เป็นแบบเลือกตอบและเติมคำ จำนวน 4 ข้อ ประเมินเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมกาสูบบุหรืติดต่อกัน
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา หรือการลดจำนวนมวนที่สูบ
ต่อวันลง

3. **รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรืโดยใช้สื่อ
นวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง** ประกอบด้วย
โปรแกรมและสื่อนวัตกรรมในการช่วยเลิกบุหรื โดยประยุกต์
ใช้รูปแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
3 ท่าน โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพและสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.80 และ 0.86 ตาม
ลำดับ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมกาสูบบุหรื
ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรื และการเลิกสูบบุหรื
ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.86, 1.00,
1.00 และ 1.00 ตามลำดับ ส่วนแบบวัดความรู้ ได้ค่า
KR-20 เท่ากับ 0.85 และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ของแบบสอบถามพฤติกรรมกาสูบบุหรื ความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับบุหรื และการเลิกสูบบุหรื ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.84

การพิทักษ์สิทธิ์ของกุ่มตัวอย่าง โครงร่างการ
วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับหนังสือ
รับรองเลขที่ PH_CCO_REC 049/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม

2566 ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการโดยการชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ก่อนลงนามยินยอม สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการวิจัยตามที่กำหนด หากกลุ่มตัวอย่างขอยุติไม่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอลถอนตัวออกจากการวิจัยได้ โดยไม่มีผลต่อการรักษาของผู้ป่วยประการใดทั้งสิ้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และรูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างได้แก่

1.1 บุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในด้านการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ จำนวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 3 คน นักจิตวิทยา 2 คน และ

1.2 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ถึงโครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาร่างเป็นรูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรม โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์มาพัฒนาร่วมกับนำรูปแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2.2 พัฒนาชุดสื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ โดยชุดสื่อนวัตกรรมประกอบด้วยแผ่นให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ การประเมินความพร้อมและการเสพติดนิโคติน และเว็บแอปพลิเคชัน (QUIT SM) ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ การประเมินการเสพติดนิโคติน ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่ และเทคนิคการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ โดยนำ

รูปแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดสื่อนวัตกรรมเช่นเดียวกัน

2.3 พัฒนาเป็นรูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ โดยใช้สื่อนวัตกรรมโดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ภาวะคุกคาม/อุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรู้ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ ตามรูปแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ โดยมีการดำเนินการ 6 กิจกรรม ได้แก่

2.3.1 การทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่พิษภัยของบุหรี่ ผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพและโรคที่ผู้ป่วยเป็น ประเมินการเสพติดนิโคตินโดยสื่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งลงบันทึกในคู่มือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และร่วมกันวางแผนในการเลิกสูบบุหรี่ ใช้ระยะเวลา 30-45 นาที

2.3.2 การทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา อภิปรายเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการสูบบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม ใช้ระยะเวลา 30 นาที

2.3.3 การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ ครั้งที่ 1 ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในรายที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ ใช้ระยะเวลา 15-30 นาที

2.3.4 การทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการจัดการตนเองที่ผ่านมาในการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทั้งประเมินการเสพติดนิโคตินโดยใช้สื่อนวัตกรรมโดยการให้ผู้ผู้ป่วยประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามแบบประเมินที่กำหนด พร้อมทั้งลงบันทึกในคู่มือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้ระยะเวลา 30 นาที

2.3.5 การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ ครั้งที่ 2 ทางโทรศัพท์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ

ช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในรายที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ ใช้ระยะเวลา 15-30 นาที

2.3.6 การประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และวางแผนในการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินการเสพติดนิโคตินโดยใช้สื่อนวัตกรรมและทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลและความพึงพอใจสื่อนวัตกรรม ใช้ระยะเวลา 40 นาที

2.4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ให้ที่ปรึกษางานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ จำนวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ จำนวน 2 ท่าน พยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมยาสูบ จำนวน 3 ท่าน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ จำนวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองใช้ (try out) รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้สื่อนวัตกรรม และเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน (QUIT SM) คือ ปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลดีของการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ทันที

ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา (content analysis) สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test

ผลการวิจัย

1. **ผลการศึกษาด้านการเลิกสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และรูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง** พบว่า ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 10 ราย ทุกคนยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 2-3 มวน ไม่ทราบว่าตนเองมีการเสพติดนิโคตินหรือติดบุหรี่มากน้อยเพียงใด และคิดว่าตนเองติดบุหรี่ไม่มาก เนื่องจากมีการสูบบุหรี่วันละ 2-3 มวนเท่านั้น มีประสบการณ์การช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีเจ้าหน้าที่สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และผลกระทบต่อสุขภาพเบื้องต้น สอบถามความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ หากต้องการเลิกจะส่งไปยังคลินิกเลิกบุหรี่ ด้านบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 5 ราย พบว่าการดำเนินการในการช่วยเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา มีการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการพูดคุยและสื่อสารด้วยวาจาเท่านั้น หากผู้ป่วยต้องการเลิกสูบบุหรี่จะดำเนินการส่งต่อไปยังคลินิกเลิกบุหรี่ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนักและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จึงต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ

2. **ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง** ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในข้อ 1 มาใช้ รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย 1) การซักประวัติการสูบบุหรี่และประเมินผู้ป่วย 2) การประเมินความพร้อม ระดับการเสพติดนิโคติน และผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อโรคประจำตัว โดยใช้ชุดสื่อนวัตกรรม 3) การกำหนดวันเลิกสูบบุหรี่ และ 4) การติดตามผลทางโทรศัพท์ ร่วมกับวันนัดหมายที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์

เมื่อสิ้นสุดการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จำนวน 5 คน ร้อยละ 18.52 สามารถลดจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันลง จำนวน 19 คน ร้อยละ 70.37 ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จำนวน 3 คน ร้อยละ 11.11 สำหรับด้านความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรม พบว่า บุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องในด้านการช่วยเลิกบุหรี่และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($M = 4.45$, $SD = 0.50$ และ $M = 4.50$, $SD = 0.46$ ตามลำดับ)

การอภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์สถานการณ์ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ บางรายยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยู่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนะวัฒน์ รวมสุข และคณะ (2564) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินพฤติกรรมสูบบุหรี่และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุหรี่และคำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่จากบุคลากร และช่วยเลิกบุหรี่จากคลินิกเลิกบุหรี่ และในส่วนของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับบุหรี่และผลกระทบต่อภาวะสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย

การพัฒนา รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนาจากการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเลิกสูบบุหรี่และข้อมูลจากผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ อันนำไปสู่การพัฒนา รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัลลิกา

มาตระกูล และนาตญา พแดนนอก (2564) ที่มีการพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่โดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยรวบรวมข้อมูลและพัฒนา รูปแบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรม พบว่า เมื่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการส่งเสริมการช่วยเลิกสูบบุหรี่ผ่านกิจกรรมและสื่อนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรู้อุปสรรคจากการเลิกสูบบุหรี่ ทำให้ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมไปถึงมีคะแนนเฉลี่ยของการเสพติดนิโคตินลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของภาวิณี แสงจันทร์ และชวนชม ธนานิธศักดิ์ (2561) ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันในการช่วยเลิกบุหรี่ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการเลิกบุหรี่ในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพสามารถให้ความรู้และประเมินการเสพติดนิโคตินของผู้ที่สูบบุหรี่ได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการและข้อมูลในการช่วยเลิกบุหรี่ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควรมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อโรคประจำตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการประเมินความพร้อมและการประเมินการเสพติดนิโคติน และควรนำรูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยใช้สื่อนวัตกรรมในแผนกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพและโรคที่เป็น รวมไปถึงได้รับการประเมินการเสพติดนิโคติน และได้รับการช่วยเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป